UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ **RECONNUE PAR L'ÉTAT** جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire : 2023-2024** **Niveau : 4ème année** **Examens Session Normale (Juin 2024)** Pr RAIS	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH

1. **Concernant les tumeurs épithéliales primitives de l'ovaire**
   - A- Sont les tumeurs les plus fréquentes de l'ovaire
   - B- Proviennent du revêtement cœlomique de surface ovarienne
   - C- Sont essentiellement malignes
   - D- Sont classées en fonction du type cellulaire et du degré de malignité
   - E- Incluent les tératomes immatures
2. **Concernant les tumeurs germinales de l'ovaire**
   - A- Le tératome ovarien mature est le plus fréquent
   - B- Proviennent des cellules de Sertoli et de Leydig
   - C- Dérivent des cellules germinales ovariennes
   - D- Le tératome mature peut cancériser
   - E- Sont retrouvés le plus souvent chez la femme jeune de moins de 20ans
3. **Concernant des tumeurs de l'ovaire**
   - A- La classification anatomopathologique la plus utilisée est celle de l'OMS 2020
   - B- La classification est fondée sur la corrélation morphologique entre l'aspect histologique tumoral et histologique des constituants de l'ovaire normal
   - C- La tumeur de l'ovaire la plus fréquente est la métastase
   - D- Les tumeurs épithéliales se développent à partir des cellules germinales
   - E- Les tumeurs des cordons sexuels et du stroma est la plus fréquente
4. **Les facteurs de risque d'un carcinome primitif de l'ovaire sont**
   - A- Antécédents familiaux de cancer de l'ovaire
   - B- Mutations des gènes BRCA
   - C- Nuliparité
   - D- Hormonothérapie substitutive
   - E- Syndrome de Lynch
5. **Les tumeurs mucineuses de l'ovaire :**
   - A- Constituent 80% des tumeurs ovariennes
   - B- Elles sont souvent bénignes
   - C- Elles peuvent se compliquer de pseudo-myxome péritonéal
   - D- Le diagnostic positif repose sur la biopsie de la tumeur
   - E- le diagnostic de cystadénocarcinome mucineux ovarien ne peut être considéré qu'après avoir éliminé une origine secondaire digestive
6. **Rôle du pathologiste dans la prise en charge du cancer du sein**
   - A- Assure le diagnostic de certitude selon la classification de l'OMS 2019
   - B- Participe avec les radiologues, chirurgiens et cancérologues à l'établissement de la démarche thérapeutique
   - C- Précise dans les cas de chirurgie conservatrice l'étendu et les limites d'exérèse
   - D- Fournit les éléments histopronostiques nécessaires à la prise en charge thérapeutique
   - E- Évalue le statut Her2
7. **La classification OMS 2019 des carcinomes <u>infiltrants</u> du sein distingue**
   - A- Carcinome mammaire de type non spécifique (NST)
   - B- Carcinome mammaire de type lobulaire
   - C- carcinome lobulaire in situ
   - D- Carcinome canalaire in situ
   - E- Carcinome tubuleux

8. Le carcinome infiltrant de type non spécifique NST

A- Est le type histologique le plus fréquent des cancers du sein
B- Est anciennement appelé carcinome canalaire infiltrant
C- Peut donner une métastase ganglionnaire axillaire
D- Peut-être bilatéral
E- Peut donner des métastases pulmonaires

9. L'évaluation du grade de Scarff Bloom Richardson est fondée sur

A- La différentiation glandulaire
B- Les embols vasculaires
C- Le pourcentage du Ki67
D- Le nombre de mitoses
E- les atypies cyto-nucléaires

10. Entourer les cancers du sein HER2 négatifs (QCU)

A- Her 2 (0)
B- Her 2 (1+)
C- Her 2 (2+) non amplifié en hybridation in situ
D- Her 2 (3+)
E- Her 2 (2+) amplifié en hybridation in situ

11. Quel fixateur utilise-t-on pour un prélèvement d'une lésion mammaire infraclinique?

A- Mélange alcool éther
B- Bouin
C- Glutaraldéhyde
D- Cytospray
E- Formol tamponné neutre à 4%

12. La mastopathie fibrokystique du sein comporte quatre des lésions suivantes :

A- La cicatrice radiaire
B- Le kyste
C- Le papillome
D- L'adénose
E- L'hyperplasie épithéliale canalaire

13. Les tumeurs du sein dont l'exérèse doit être large sont :

A- La mastite granulomateuse
B- Tumeur phyllode grade II
C- Adenomyoépithéliome
D- Fibromatose
E- Adénofibrome mammaire

14. Une des propositions suivantes s'applique à la tumeur phyllode du sein, laquelle ?

A- Dystrophie mammaire
B- Se cancérise toujours
C- Double composante épithéliale et conjonctive
D- Squirrhe
E- Récidive après exérèse complète

15. La cicatrice radiaire :

A- Appartient au spectre des mastopathies fibro-kystiques
B- Est d'image stellaire à la mammographie
C- Est à risque quand elle mesure moins de 7mm
D- Est un type de cancer de sein
E- Pose le problème de diagnostic différentiel à l'échelle radiologique avec un cancer infiltrant du sein

16. Le lymphome de hodgkin

A- Est une maladie curable
B- Le début est souvent stéréotypé
C- Nécessite un bilan d'extension complet
D- Le stade d'Ann Arbor détermine le pronostic et les indications thérapeutiques.
E- Nécessite une étude immunohistochimique

17. Les quatre sous-types du lymphome hodgkinien classique sont :

A- Sous-type scléronodulaire
B- Sous-type à cellularité mixte
C- Sous-type riche en lymphocytes
D- Sous-type en déplétion lymphocytaire
E- Nodulaire à prédominance lymphocytaire

18. Les trois principaux anticorps orientant vers le diagnostic d'un lymphome hodgkinien classique

A- Anticorps anti CD15
B- Anticorps anti CD3
C- Anticorps anti PAX5
D- Anticorps anti CD30
E- Anticorps anti CD20

19. Une lésion polypoide colorectale :

A. Peut être de nature inflammatoire
B. est toujours un adénome colorectal
C. Doit être vérifiée histologiquement
D. Peut correspondre à de nombreuses entités anatomo-cliniques différentes
E. Est toujours bénigne

20. Le compte rendu anatomopathologique en matière de cancer rectal doit préciser:

A. La limite circonférentielle
B. Le degré de différentiation des adénocarcinomes
C. La présence ou non d'emboles vasculaires
D. Le type histologique
E. L'état des limites d'exérèse chirurgicales

21. Les critères de risque de malignité devant un adénome colorectal englobent :

A. L'âge >60ans
B. Le sexe masculin
C. La composante villeu chocolat se
D. La taille > 1cm
E. Le siège rectal

22. Concernant l'origine tissulaire des tumeurs primitives hépatiques

A. Le carcinome hépatocellulaire provient des structures hépatocytaires
B. Le cholangiocarcinome provient des structures biliaires
C. Les structures vasculaires ne donnent pas de tumeurs primitives hépatiques
D. Il peut exister des tumeurs mixtes
E. Il peut exister des tumeurs d'origine embryonnaire

23. La localisation secondaire au niveau hépatique d'une tumeur maligne

A- Est plus fréquente qu'une tumeur primitive
B- Est le plus souvent due à un néoplasme d'origine digestive
C- Est le plus souvent multinodulaire
D- L'immunohistochimie à elle seule peut toujours déterminer le primitif avec précision
E- Peut-être révélatrice d'un cancer

24. Le cancer primitif du poumon :

A- Est dominé par les carcinomes
B- Est dû principalement au tabac
C- Peut survenir sur un lit de dysplasie
D- Est de bon pronostic
E- Peut Poser le problème de diagnostic différentiel avec une métastase

25. Le carcinome épidermoide du poumon:

A- Est souvent périphérique
B- Peut-être nécrosé et excavé
C- Est bien, moyennement ou peu différencié
D- Peut être confondu avec une métastase
E- N'est pas lié au tabagisme

26. Quel est la tumeur testiculaire la plus fréquente ?

A- Le carcinome embryonnaire
B- Le tératome
C- Le choriocarcinome
D- Le séminome
E- Le yolk sac tumor

27. Devant une suspicion de tumeur testiculaire, le diagnostic se fait sur :

A- Une cytoponction
B- Une biopsie
C- Des copeaux de résection endoscopique
D- Une orchidectomie
E- Une exérèse partielle

28. Vous recevez au laboratoire un prélèvement pour tumeur testiculaire. A la coupe, la tumeur est bien limitée, homogène de couleur beige-rosé. A ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ?

A- Le carcinome embryonnaire
B- Le tératome
C- Le choriocarcinome
D- Le séminome
E- Le yolk sac tumor

29. Dans ce cas, vous trouverez à l'examen histologique :

A- Des cellules tumorales associées à des lymphocytes et des granulomes
B- Des tubes, cordons et massifs formés de cellules monomorphes atypiques
C- Des corps de Shiller Duval
D- Des globes cornées
E- Un infiltrat de cellules en bague à chatons

30. Vous décidez de faire une étude immunohistochimique pour vous aider dans votre diagnostic. Quel est l'anticorps qui sera positif ?

A- bHCG
B- αFP
C- PLAP
D- CD30
E- Tdt

31. Vous recevez au laboratoire une pièce de néphrectomie pour tumeur rénale. A la coupe, la tumeur est volumineuse et mesure 8 cm. A la coupe est bien limité, non encapsulé de couleur beige. L'examen approfondi de la pièce, macroscopiquement, ne met pas en évidence de cicatrice fibreuse stellaire centrale. A ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ?

A- Un carcinome chromophobe
B- Un carcinome tubulo-papillaire
C- Un carcinome des tubes collecteurs
D- Un carcinome à cellules claires
E- Un carcinome médullaire

32. L'absence de cicatrice fibreuse stellaire centrale, le caractère non encapsulé et la taille volumineuse permettent d'éliminer une autre tumeur. Laquelle ?

A- L'angiomyolipome
B- L'adénome papillaire
C- L'adénome métanephrique
D- L'oncocytome
E- Le néphrome mesoblastique

33. Vous recevez un appel d'un chirurgien travaillant à distance de tout laboratoire, il souhaite vous envoyez un ganglion pour examen anatomopathologique. Le patient présente plusieurs adénopathies au niveau cervical et inguinal. Vous lui conseillez de : (3 réponses attendues)

A- Privilégier le site inguinal
B- Privilégier le site cervical
C- De faire une biopsie partielle
D- De faire une biopsie exérèse
E- De fournir des renseignements cliniques complets

34. Le ganglion sera choisi sur son aspect macroscopique à savoir le caractère :

A- Rond
B- Mobile
C- Dur
D- Réniforme
E- Fixe

35. Concernant le conditionnement du ganglion, Le chirurgien devra pour le grand ganglion prélevé:

A- L'envoyer à l'état frais
B- Le couper en deux
C- Faire des appositions
D- Le mettre dans une compresse imbibée de sérum physiologique
E- Le fixer

36- Quels sont les conditions optimales pour la bonne prise en charge du fragment de la responsabilité du clinicien ?

A- Le remplissage le plus complet possible des renseignements cliniques
B- L'envoi d'un bon d'examen vide sans information clinique
C- L'étiquetage du prélèvement avec le nom du patient
D- L'envoi du fragment à l'étroit dans un très petit flacon
E- L'envoi du prélèvement au laboratoire 3 jours après le geste

37- Le chirurgien décide de fixer le prélèvement. Quel fixateur lui conseillez-vous ?

A- Le liquide de Bouin
B- Le Bicarbonate
C- L'alcool
D- Le Formol
E- Le sérum salé

38- A quel pourcentage le formol devra être dilué ?

A- 10 % B- 20 % C- 30 %
D- 60 % E- 70 %

39. Arrivé au laboratoire, vous examinez le ganglion. Vous notez un aspect chair de poisson. A ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ?

A- Un sarcome
B- Un carcinome
C- Un mélanome
D- Un séminome
E- Un lymphome

40. Dans ce cas, vous trouverez à l'examen histologique :

A- Une prolifération tumorale fusocellulaire
B- Des boyaux de cellules jointives avec des globes cornées
C- Un infiltrat de cellules lymphomateuses
D- Une prolifération riche en cellules en bague à chatons
E- Une prolifération à cellules claires

41. L'examen au plus fort grossissement met en évidence des cellules tumorales monomorphes à noyau clivé. Vous vous orientez vers :

A- Un adénocarcinome
B- Un carcinome épidermoïde
C- Un lymphome du manteau
D- Un myélome
E- Un teratome

42. Vous décidez de faire une étude immunohistochimique pour vous aider dans votre diagnostic. Quel est le premier panel d'anticorps que vous allez utiliser ?

A- Cytokératine20
B- CD20
C- Cytokératine7
D- CD3
E- PS100

43. Quel est l'anticorps qui sera positif ?

A- Cytokératine20
B- CD20
C- Cytokératine7

D- CD3
E- PS100

44. Vous compléterez votre étude immunohistochimique par un autre anticorps. Lequel ?

A- Tdt
B- Kappa
C- CD30
D- Bcl2
E- Cyclin D1

45. Devant une suspicion de métastase ganglionnaire, le premier site d'invasion ganglionnaire est à rechercher au niveau?

A- De la zone folliculaire
B- De la zone parafolliculaire
C- De la médullaire
D- De la pulpe rouge
E- En sous-capsulaire

46. Devant une suspicion de lymphome lymphoblastique T, quels sont les 2 examens immunohistochmiques que vous allez demander pour le diagnostic ?

A- Bcl1 B- CD3 C- Tdt
D- Ki67 E- CD20

47. Une prolifération lymphomateuse exprimant le CD20 avec un ki67 à 100 % est probablement :

A- Un lymphome B
B- Un lymphome d'Hodgkin
C- Un lymphome T
D- Un lymphome de Burkitt
E- Un myélome multiple

48. Dans ce cas particulier, il existe 2 localisations, particulièrement, caractéristiques. Lesquels :

A- L'atteinte Cérébrale
B- L'atteinte Pulmonaire
C- L'atteinte iléo-coecale
D- L'atteinte gastrique
E- L'atteinte mandibulaire

49. Devant une tumeur papillaire de la vessie composée de papilles épaisses et fusionnées avec une désorganisation architecturale majeure et atypies marquées, vous concluez à ?

A- Un papillome
B- Une néoplasie papillaire de faible potentiel de malignité
C- Un carcinome papillaire de bas grade
D- Un carcinome papillaire de haut grade
E- Un carcinome In Situ

50. Dans ce cas, cocher les réponses correctes concernant le facteur histo-pronostic majeur ayant des répercussions chirurgicales sur le plan de la prise en charge thérapeutique ?

A- Une infiltration du muscle Quadriceps
B- Une infiltration de la musculaire-muqueuse
C- Une infiltration de la musculeuse
D- Une infiltration du muscle Detrusor
E- Un stade pT2

4ème Année

Session normale 7 ai 2024

Anatomie pathologique

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☒	☒	☒
Q3	☒	☒	☐	☐	☐
Q4	☒	☒	☒	☒	☐
Q5	☐	☒	☒	☐	☒
Q6	☒	☒	☒	☒	☒
Q7	☒	☒	☐	☐	☒
Q8	☒	☒	☒	☒	☒
Q9	☒	☐	☐	☒	☒
Q10	☒	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☒
Q12	☒	☒	☐	☒	☒
Q13	☐	☒	☒	☒	☐
Q14	☐	☐	☒	☐	☐
Q15	☒	☒	☐	☐	☒
Q16	☒	☒	☒	☒	☒
Q17	☒	☒	☒	☒	☐
Q18	☒	☐	☒	☒	☒
Q19	☒	☐	☒	☒	☐
Q20	☒	☒	☒	☒	☒
Q21	☒	☒	☒	☒	☒
Q22	☒	☒	☐	☒	☒
Q23	☒	☒	☒	☐	☒
Q24	☒	☒	☒	☐	☒
Q25	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☐	☐	☒	☐
Q27	☐	☐	☐	☒	☐
Q28	☐	☐	☐	☒	☐
Q29	☒	☐	☐	☐	☐
Q30	☐	☐	☒	☐	☐
Q31	☒	☐	☐	☐	☐
Q32	☐	☐	☐	☒	☐
Q33	☐	☒	☐	☒	☒
Q34	☒	☐	☒	☐	☒
Q35	☐	☒	☒	☐	☒
Q36	☒	☐	☒	☐	☐
Q37	☐	☐	☐	☒	☐
Q38	☒	☐	☐	☐	☐
Q39	☐	☐	☐	☐	☒
Q40	☐	☐	☒	☐	☐
Q41	☐	☐	☒	☐	☐
Q42	☐	☒	☐	☒	☐
Q43	☐	☒	☐	☐	☐
Q44	☐	☐	☐	☐	☒
Q45	☐	☐	☐	☐	☒
Q46	☐	☒	☒	☐	☐
Q47	☐	☐	☐	☒	☐
Q48	☐	☐	☒	☐	☒
Q49	☐	☐	☐	☒	☐
Q50	☐	☐	☒	☒	☒

Royaume du Maroc
Hôpital ARRAZI
Ministère de la Santé

Pr. RAIS HANANE
Chef de service
d'Anatomie Pathologique
Hôpital ARRAZI